Lineamiento Técnico **Criterios de referencia del I al II Nivel . Especialidad de Cirugía Pediátrica.**	
Elaborado por:	Área de Atención Integral a las Personas Con aportes de: • Dra. Laura Rosales Rosas. Servicio de Consulta Externa Hospital Nacional de Niños Dr Carlos Sáenz Herrera • Dr. Jaime Cortés Ojeda, Cirujano pediatra. Departamento de Cirugía Hospital Nacional de Niños Dr Carlos Sáenz Herrera • Dr. Roberth Moya Vazquez, Pediatra. Servicio de Pediatría Hospital Dr Carlos Luis Valverde Vega. • Dra. Ana Gabriela Naranjo Arias. Servicio de Cirugía Pediátrica Hospital San Vicente de Paúl • Dra Norma Ceciliano Romero. Cirujano pediatra jubilada.
Para:	Funcionarios del I Nivel de Atención de la CCSS

Relación con Normativa Vigente

- Caja Costarricense de Seguro Social. Hospital Nacional de Niños. (2016) Criterios de referencia a la consulta externa.
- CCSS. GM.Proyecto de fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud. Dirección Regional de servicios de salud Huetar Atlántica. (2017) Guía de criterios de referencia del I al II Nivel de Atención avalado para su implementación según oficio GM-S-29385-2017 del 21 de setiembre 2017.

Justificación

Con la publicación de los criterios incluídos en este documento se pretende contribuir a mejorar los procesos de referencia entre el I y II Nivel de atención en el país considerando las patologías pediátricas prevalentes que requieren atención quirúrgica.

Objetivo

Establecer los criterios de referencia de usuarios desde el Primer Nivel de Atención hacia la especialidad de Cirugía Pediátrica en el establecimiento correspondiente según red de servicios.

Fundamentación del lineamiento

Uno de los objetivos considerados en el Plan Táctico de la Gerencia Médica 2019-2022 es "Disminuir el número promedio de días de espera máxima para la prestación de la Consulta Médica Especializada".
En atención a cumplir con lo planteado en este objetivo , se requiere optimizar el proceso de referencia hacia las especialidades , con el fin de que se realicen las derivaciones requeridas en el momento oportuno.

En atención a lo planteado, se presentan en este documento los criterios de referencia para un listado de patologías basado en el definido en la ***Guía de criterios de referencia del I al II Nivel de Atencion*** avalada para su implementación según oficio GM-S-29385-2017 del 21 de setiembre 2017 y que corresponde a las condiciones que los establecimientos de salud de la red consideran estadísticamente de mayor relevancia en la consulta externa.

Descripción del lineamiento

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes que se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:

- Datos generales del centro de procedencia (nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha).
- Datos de identificación del usuario
- Antecedentes heredofamiliares relevantes para la evolución de la patología, antecedentes personales de alergia a medicamentos, antecedentes patológicos y quirúrgicos.
- Descripcion de sintomatología, tiempo de evolución y tratamiento recibido
- Valoracion antropométrica y resumen de hallazgos relevantes de examen físico completo.
- Resultados de exámenes de laboratorio y gabinete realizados al usuario que

tengan relación directa con el motivo de referencia

- **Justificación del motivo de referencia**. Diagnóstico por el cual se refiere al paciente o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever por qué se agotó la capacidad resolutiva del Primer Nivel.

3. Se recuerda que NO corresponde referir a Consulta Externa de CIRUGÍA PEDIÁTRICA por parte de I Nivel de Atención las siguientes condiciones:

CONDICIÓN	CORRESPONDE REFERIR A
ADENOPATÍAS	Pediatría
CRANEOSINOSTOSIS	
CONSTIPACIÓN (estreñimiento)	
DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO	
REFLUJO GASTROESOFÁGICO	
HEMANGIOMAS	PEDIATRÍA o Dermatología
MALFORMACIONES UROGENITALES (Hipospadias, Epispadias)	UROLOGÍA o Pediatría si hay duda diagnóstica
VARICOCELE	UROLOGÍA en la adolescencia Se refieren antes si están sintomáticos o el testítulo retrocede con el crecimiento
NEVUS	DERMATOLOGÍA o Pediatría
DOLOR ABDOMINAL AGUDO ESCROTO AGUDO SANGRADO DIGESTIVO MASA ABDOMINAL MASA TORÁXICA PARAFIMOSIS	URGENCIAS

A continuación se resumen las indicaciones generales para referencia a Cirugía Pediátrica presentando las patologías priorizadas ordenadas de manera alfabética y estableciendo el grado de prioridad para su citación.

ABSCESO PERIANAL

Criterios de priorización : **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir a Cirugía si persiste después del año de edad	Antes del año de edad corresponde manejo por Pediatría

ADHERENCIAS DE LABIOS MENORES EN NIÑAS PREPUBERALES

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
En caso de persistir fusión de labios menores a pesar del tratamiento en pacientes sintomáticas	<u>Usuarias asintomáticas</u> Condición transitoria, más frecuente entre el año y los dos años de edad . La mayor parte resuelven espontáneamente con la pubertad NO DAR TRATAMIENTO NI ENVIAR A CIRUGÍA. <u>Usuarias sintomáticas</u> Infecciones urinarias, dificultad para la micción, dolor o irritación Tratamiento: Crema de estrógenos conjugados al 0.625 bid por 14 días, seguido por masaje con presión con vaselina bid hasta que se separen los labios / masaje con betametasona al 0.05% tid por un mes

CRIPTORQUIDIA

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir después de los 6 meses de edad	Testículos no palpables bilateral por médico general, solicitar de inmediato valoración por pediatra

FÍSTULA y APÉNDICE PREAURICULAR

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir apéndices preauriculares al momento de diagnosticar	Fístulas se operan solo si están sintomáticas En HNN: son operados por Cirugia Reconstructiva

FISTULA PERIANAL

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Mas de 1 año de edad si recurre más de 3 veces	La mayoría son consecuencia de un absceso perianal

FIMOSIS

Criterio de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir de inmediato si hay obstrucción o infección del tracto urinario	Considerar referencia a Urgencias si la obstrucción es severa

Criterio de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Se refieren a los 3 años si no han resuelto independiente del grado	Se recomienda: retraer el prepucio sin forzar, aplicando betametasona alrededor, contar por 10 segundos y volver a relajar. Repetir 10 veces este procedimiento, mañana y tarde por 2 meses

FRENILLO SUBLINGUAL

Criterios de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Al momento de diagnosticar, si se asocia con problemas de alimentación o lenguaje	Atendido por Odontología, en algunos establecimientos de salud En HNN: son operados por Cirugía Maxilo Facial.

GINECOMASTIA

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Se refieren alrededor de los 14 años de edad	Esperar mínino 2 años después de su aparición , valorar si está compuesta por tejido mamario y grasa orientando el manejo a la obesidad, en caso de existir

HERNIA EPIGÁSTRICA

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir solamente si son sintomáticas	Realizar diagnóstico diferencial con diastasis de rectos abdominales

HERNIA INGUINAL

Criterios de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir al diagnosticar	Prioridad Pretérminos

HERNIA UMBILICAL

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Mayor 5 años o si es sintomática	

HIDROCELE

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Mayor de 12 meses	Si se presenta a tensión referir a Urgencias para descartar hernia encarcelada

PECTUS CARINATUM[1]

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Afectacion psicológica en relación con la deformidad Factor estético	En HNN son operados por Cirugia de Torax

[1] Bento,L. et al.(1997) Pectus excavatum y pectus carinatum. Indicaciones quirúrgicas en el niño.Bol.S Vasco-Nav Pediatr .31:90-95. En: http://www.svnp.es/sites/default/files/31-2-90.pdf

PECTUS EXCAVATUM

Criterios de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Pacientes sintomáticos con sintomas progresivos Problemas respiratorios y cardiacos Alteracion psicológica relacionada con la deformidad Cambios posicionales en la columna vertebral secundarios a la deformidad toraxica	En HNN son operados por Cirugia de Torax

QUISTE TIROGLOSO

Criterios de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir al momento de diagnosticar	Se requiere US cuello y pruebas de función tiroidea

QUISTES O FISTULAS CERVICALES (incluye branquiales)

Criterios de priorización: **Prioridad**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir al momento de diagnosticar	Diferenciar de adenopatías, descartar tiroides ectópica.

QUISTE COLA DE LA CEJA

Criterios de priorización: **A cupo**

Criterios de referencia	Observaciones
Referir al momento de diagnosticar	 [2]

Responsable del cumplimiento

- Personal de medicina del Primer Nivel de Atención
- Especialistas en cirugía pediátrica

Responsable de verificar el cumplimiento

- Directores de Áreas de Salud y Hospitales
- Jefes de Consulta Externa
- Coordinadores de Gestión de Enlace Interniveles

Responsable de Monitoreo y evaluación

- Directores de Áreas de Salud y Hospitales
- Jefes de Consulta Externa
- Coordinadores de Gestión de Enlace Interniveles

[2] Hospital Materno Infantil Miguel Servet. Cirugia Pediatrica.QUISTE DE COLA DE CEJA .En: http://cirugiapediatrica.zaragoza2.salud.aragon.es/assets/procedimientos/quiste_cola_ceja.pdf

- Direccion de Red de Servicios de Salud

Contacto para consultas:

- Área Intención Integral a las Personas
- Correo electrónico: corraaipccss.sa.cr
- Teléfono: 2223-8948

Referencias

Bento,L. et al.(1997) Pectus excavatum y pectus carinatum. Indicaciones quirúrgicas en el niño.Bol.S Vasco-Nav Pediatr .31:90-95. En: http://www.svnp.es/sites/default/files/31-2-90.pdf

Caja Costarricense de Seguro Social. Hospital Nacional de Niños. (2016) Criterios de referencia a la consulta externa.

Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia Medica.Proyecto de fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud. Direccion Regional de servicios de salud Huetar Atlantica. (2017) Guia de criterios de referencia del I al II Nivel de Atencion avalado para su implementación según oficio GM-S-29385-2017 del 21 de setiembre 2017.

Hospital Materno Infantil Miguel Servet. Cirugia Pediatrica.QUISTE DE COLA DE CEJA .En: http://cirugiapediatrica.zaragoza2.salud.aragon.es/assets/procedimientos/quiste_cola_ceja.pdf